

TEMA 4.16 • DERMATOLOGÍA

Prurigo

PERFIL EUNACOM 6.01.2.002

Dx: Específico • Tx: Completo • Seg: Completo

Dermatosis Agudas Exógenas Asociadas a Luz Solar (UV)

Conjunto de patologías cutáneas de estallido agudo detonadas ante la incidencia radiante natural, en las cuales la irradiación de los fotones UV es la mecha basal central obligatoria para la irritación clínica tisular, ya sea primariamente o bajo la activación mediada de agentes químicos.

1. Reacción Fototóxica Directa (Fototoxicidad por Fármacos)

- **Fisiopatología Estructural Causal:** Representa un daño abrasivo tisular **NO INMUNOLÓGICO Y NO ALÉRGICO**. Consiste netamente en que algún medicamento o compuesto exógeno ingerido/aplicado es inofensivo basalmente, pero al entrar paralelo en colisión estructural con la irradiación solar Luz Ultravioleta, su molécula se transforma a la fuerza en un veneno químico Citotóxico abrasivo mortal matando las células epidérmicas colindantes por tóxico. -

Cuadro Clínico Simil Estructural: Resulta invariablemente la manifestación clínica grosera similar a un embate de franca **Quemadura Solar Inmensa Fuerte (Eritemas severos con ampollaje agudo rotundo)** limitados estrictamente de frontera a la porción de piel abierta que fue embestida por la línea de fuego de luz del sol. - **Los Detonantes Farmacológicos Clásicos EUNACOM (Sospecha basal obligada en toda quemadura oral atípica):** 1. *Familia de Antibióticos Fluorquinolonas (Ciprofloxacino) y de Familia Tetraciclinas (Doxiciclina).* 2. *El fármaco acnéico extremo y severo Isotretinoína Oral (Razón principal de su letal daño quemado sin filtro).* 3. Los antiinflamatorios AINEs.

2. Reacción Fotoalérgica (La Fitofotodermatitis Estacional)

- **Fisiopatología Inmunológica Secundaria Causal:** En neto contraste a la fototóxica primaria; esta cursa por hipersensibilidad estacional cruzada basal **TOTAL Y Estrictamente INMUNOLÓGICA TIPO ALERGIA**. En esta el contacto primario del alérgeno no es letal, sólo sensibiliza cruzado con alérgeno y requiere que medie tardíamente el accionar sol para que la inmunidad exacerbe e incinere la base (Ej. La llamada *Fitofotodermatitis*: Reacción inflamatoria letal por cruces con jugos de Plantas/Vegetación + Rayo del Sol agresivos de base). - **Los Inoculadores Botánicos Clásicos Estacionales ("La típica de Verano"):** 1. **El Árbol de la Ceba "Litre":** Clásico del cerro precordillerano exótico nacional. Arroja su resina al paciente cruzado y al asolearse brotan placas. Su signo morfológico es cruza directa patognomónica vesiculosa en las famosas

"Erupciones de Ampollaje de trayecto Lineal del ramas (Por el roce botánico botando su rancio estiramiento)". 2. **El Exprimido Ácido de la Lima / Limón Verde (Limón Pica / Sutil):** Patología de verano endémica o parrillera. Restos cruzados asediantes exóticos cítricos asoleados que asfixian y exacerbaban manos basales crudas con rojeces y dolor punzante, resultando en crónicas cicatrices de inmaculadas **Severas Hiperpigmentación oscura digital posterior duradera o prolongada semanas al incidente.**

(Las quemaduras o reacciones de fototoxicidad basal tratadas sintomáticamente derivan como primera instancia al apaciguamiento estruendo pasivo a base transversal al control sintomático estéril en reposiciones perimetrales y cruzados asiduos desinflamatorios agudos con el corticoide tópico de rescate asociado perimetral en la placa de ardor).

CASO CLÍNICO TIPO EUNACOM**ESCENARIO CLÍNICO TÍPICO:**

"¿Cuál es la diferencia clave entre el prurigo insectario y la varicela?"

EXPLICACIÓN CLÍNICA DETALLADA:

Manejo clínico y diagnóstico según normativa MINSAL y perfil EUNACOM para Prurigo. Priorizar reconocimiento precoz y tratamiento de primera línea.

PUNTOS CLAVE DESTACADOS

- El prurigo insectario es causado por picaduras de insectos y afecta principalmente a niños.
- El prurigo insectario NO afecta el área del pañal, lo que lo diferencia de la varicela.
- El prurigo insectario es autolimitado y se trata con antihistamínicos orales.
- El prurigo nodular es autoinmune con nódulos escoriados crónicos en zonas extensoras.
- El prurigo nodular respeta la zona centrolumbar por ser de difícil acceso para el rascado.
- El tratamiento del prurigo nodular incluye corticoides tópicos de alta potencia.
- El dupilumab está indicado en prurigo nodular refractario a los tratamientos convencionales.

EVALUACIÓN DE CLASE Y PREGUNTAS TIPO EUNACOM (PRURIGO)

PREGUNTA 1

¿Cuál es la diferencia clave entre el prurigo insectario y la varicela?

- A)** El prurigo tiene vesículas umbilicadas y la varicela tiene vesículas en forma de gota
- B)** El prurigo insectario no afecta el área del pañal a diferencia de la varicela
- C)** El prurigo afecta mucosas orales y la varicela respeta completamente las mucosas
- D)** El prurigo produce costras hemorrágicas y la varicela produce costras melicéricas
- E)** El prurigo solo afecta una extremidad y la varicela siempre es bilateral y simétrica

PREGUNTA 2

¿Cuál es la característica clínica más importante del prurigo nodular?

- A)** Vesículas tensas bilaterales en palmas y plantas con prurito nocturno intenso
- B)** Nódulos múltiples escoriados muy pruriginosos en zonas extensoras con respeto centrolumbar
- C)** Placas eritematodescamativas en codos y rodillas con raspado positivo de Brocq
- D)** Ampollas flácidas con signo de Nikolsky positivo en tronco y extremidades
- E)** Pápulas urticarianas transitorias que desaparecen en menos de veinticuatro horas

PREGUNTA 3

¿Cuál es el tratamiento de primera línea para el prurigo insectario en un niño?

- A)** Corticoides tópicos de alta potencia como clobetasol dos veces al día
- B)** Antihistamínicos orales para controlar el prurito y las reacciones alérgicas
- C)** Antibióticos orales con cobertura para estafilococo por riesgo de sobreinfección
- D)** Dupilumab subcutáneo para los casos graves que no responden a medidas básicas
- E)** Ivermectina oral para eliminar los ácaros causantes del cuadro pruriginoso

RESUMEN: PRURIGO

El prurigo incluye dos entidades distintas. El prurigo simple o insectario es causado por picaduras de insectos, especialmente pulgas y mosquitos, y se presenta principalmente en la edad pediátrica. Se caracteriza por pápulas y pequeñas vesículas muy pruriginosas distribuidas en zonas expuestas, con una característica clave: no afecta el área del pañal, lo que lo diferencia de la varicela que tampoco respeta esa zona. El cuadro es autolimitado y el tratamiento son los antihistamínicos orales. El prurigo nodular es una enfermedad autoinmune diferente, que se caracteriza por nódulos múltiples escoriados muy pruriginosos, de superficie rugosa, localizados preferentemente en las zonas extensoras de extremidades, con respeto de la zona centrolumbar de difícil acceso para el rascado. El curso es crónico con gran impacto en la calidad de vida. El tratamiento incluye corticoides tópicos de alta potencia y el biológico dupilumab para los casos refractarios.